

09 - Les vascularites à ANCA - Pr. Essadouni

(0:02 - 0:34)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé Les vascularites à Anka. Ces vascularites, c'est un groupe d'infections qui sont très hétérogènes sur le plan clinique mais qui ont également des similitudes cliniques et aussi sérologiques. C'est des infections caractérisées par une inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins qu'il s'agisse de vaisseaux de grand calibre, de petit calibre et de moyen calibre.

(0:35 - 0:50)

Ça peut toucher également les capillaires et les veines. Dans cette entité, il y a trois maladies principales. Il y a la granulomatose avec polyangélique anciennement appelée maladie de Leuvenier.

(0:51 - 1:16)

Il y a le syndrome de Sogge-Frauss et il y a la polyangélique microscopique. Pour ce faire, on va voir ensemble la classification des vascularites systémiques. Cette classification a été étudiée en 2012 et elle se base sur la paroi des vaisseaux, sur le diamètre de la paroi des vaisseaux pour faire cette classification.

(1:17 - 1:53)

Déjà, on peut distinguer ici les vascularites qui touchent les vaisseaux de gros calibre et les vascularites qui touchent les vaisseaux de petit calibre. On a ici deux affections, essentiellement l'artérite de Takayashi et l'artérite aortale ou maladie de Horton. On a les vascularites qui touchent les vaisseaux de moyen calibre où vous avez deux entités, la périartérite nodulaire et la maladie de Takayashi et les vascularites qui touchent les vaisseaux de calibre de petit à moyen.

(1:53 - 2:09)

Et là, vous avez la polyangéite microscopique, la polyangéite avec granulomatose, appelée aussi maladie de Wegener. Et vous avez aussi la polyangéite pauci-sanguine granulomateuse. C'est anciennement appelée la maladie de Schönlein-Henoch.

(2:10 - 2:56)

Au plan physiopathologique, ces affections sont expliquées par le fait qu'il y a un dérèglement du système immunitaire avec un facteur favorisant qui peut être un facteur viral ou environnemental. Et ce dérèglement du système immunitaire va aboutir à la production d'anticorps qui vont être dirigés contre l'endothélium de cellules vasculaires, à la production de complexes immuns circulants et à l'activation de l'impulsateur laquelle activation va entraîner une hyperproduction de

cytokines avec des lésions vasculaires qui expliquent toute la symptomatologie clinique de l'analyse. Alors, on va voir ces cours à partir de deux cas cliniques.

(2:56 - 3:18)

Le premier est celui d'un patient âgé de 58 ans, qui admis pour remplir sera des membres inférieurs au volume de 15 jours. Et ce patient a des antécédents de rhinorrhée purulente depuis trois mois. L'examen clinique de ce patient trouve une tension artérielle normale avec une température à 36,5°C et un peu à 80°C.

(3:20 - 3:59)

Voici l'exemple d'un turtura vestulaire. Il est infiltré et les turturas ne s'effaçant pas avec trop de pression. Sur le plan de l'hémogramme, ce patient présente une terre necrophytoge à 3,1 µH avec une aïe aux inoxydifis, un taux d'hémoglobine à 10 g, une petite thrombocytose à 450 mm avec un taux de création mine et de réactivité 100 mm et un syndrome biologique inflammatoire avec une vitesse de sédimentation à 60 mm la première heure, une CRT à 50 mg par litre et un fibrinogène à 5 g par litre.

(3:59 - 4:55)

Sur la bandelette urinaire, on a une protéinerie positive 3 croix, une hématurie également positive 3 croix ce qui témoigne de l'activité du régime urinoire. Quel bilan demandez-vous ces patients ? Bien sûr, le premier diagnostic à évoquer ces patients, ce sont des vascularistes chimiques vu les antécédents d'infections horaires à répétition, le distance de ce que sera vasculaire au moment inférieur, mais également le distance de l'encontrement. Nous, du B, des réservistes du vasculaire chimique, on demandera un bilan immunologique et on va rechercher la présence d'un type anti-cytoplasme polynucléaire neutrophile qui sont peut-être des antipores qui ont une priorité en cytoplasme ou alors périmum nucléaire.

(4:56 - 5:20)

Une radiographie pulmonaire à la recherche d'un filtre témoignant de l'expansion vers le poumon. Un électromyogramme de façon systématique à la recherche d'une neuropathie périphérique qui peut être transplastique. Une protéinerie du C24 et une biopsie rénale en fonction du niveau de la protéinerie.

(5:20 - 5:40)

On peut demander aussi, chez ce patient, une neurographie cardiaque, des hémocultures, des PCR virales, pour éliminer certaines diagnostics. Alors, diagnostic confirmé, si ce patient est celui d'une maladie urinaire. Et on passe au deuxième cas clinique.

(5:41 - 6:09)

C'est un patient qui a vécu 67 ans qui est conçu pour une paralysie d'une sciatique populaire. Et qui a, comme antéposant, une obstruction nasale chronique bilatérale avec un asthme cortico-dépendant. Alors, chez ce patient, la rhinoscopie antérieure prouve une polypose naso-sinusalienne bilatérale avec obstruction quasi complète de deux poches nasales et une hyperhidrosomie qui délimite 200 éléments par millimètre.

(6:10 - 6:32)

Quel bilan demander ? Là aussi, on est très orienté à faire diagnostic d'une vascularite systémique. Parce qu'en fait, il y a une atteinte aux nerfs. C'est-à-dire, une aggrégation avec obstruction nasale, polypose et une hélophobie avec une athèse neurologique périphérique associée de paralysie d'une sciatique populaire.

(6:32 - 6:53)

Alors, le bilan qu'on va demander, c'est bien entendu le 2H2. C'est-à-dire, on peut remplir toute la classe de polynucléaire. Alors, dans le cas de cette atteinte, qui est la maladie de George Strauss, très diagnostique, très évident chez ce patient, c'est essentiellement les faits en temps qui sont positifs.

(6:54 - 7:19)

Bien sûr, le bilan radiologique avec une radiographie et un électromyogramme pour caractériser cette atteinte neurologique. Le diagnostic confirmé chez ce patient c'est celui de maladie de George Strauss. Alors, quelles sont maintenant les circonstances diagnostiques ou alors les circonstances de découverte de cette vascularite psychologique ou alors vascularite par un cas.

(7:20 - 7:43)

Alors, le patient soit, s'il a une altération de l'oxygène de la sphère vésicale, il peut venir consulter pour un syndrome de Drill ou alors un syndrome inflammatoire non expliqué. Alors, on a vu, chez le premier patient, il y avait un persérat vasculaire qui était très positif. On peut avoir des grains, des exulcérations, des viscérations du visage et des manifestations asphyxiques, asphyxie d'arthralgie inflammatoire ou alors d'arthrite.

(7:44 - 8:00)

Alors, toujours dans les circonstances de découverte, il y a l'atteinte neurologique, c'est-à-dire l'atteinte périphérique asphyxique de mesquinerie, c'est le problème neuropathique. On peut avoir des myalgies. L'atteinte rénale, dans la majorité des cas, c'est une atteinte rénale grave et qui peut presser rapidement.

(8:01 - 8:18)

C'est un type de glomerulonésthèse rapidement progressive. Les patients peuvent rapidement évoluer vers l'insuffisance rénale terminale et la dialyse. Une atteinte pulmonaire, un type de module pulmonaire, dans le cas de la maladie de Wegener ou alors des atteintes systémiques DLR.

(8:18 - 9:08)

Une atteinte rénale ou alors des infarctus vasculaires avec des atteintes et des atteintes systémiques. On a 3 thérapeutiques pour l'atteinte rénale systémique. Quelle est la conduite à tenir de l'atteinte de l'atteinte systémique ? Bien sûr, il faut faire les diagnostics positifs.

(9:09 - 9:31)

Il faut éliminer les diagnostics différentiels, établir le pronostic de cette atteinte et aussi mettre en risque un traitement adéquat. Ce qui est du diagnostic positif, ça repose sur l'interrogatoire à la recherche de signes d'orientation tel que l'altération de l'état général, la fièvre. Ce sont des signes qui sont généraux et qui peuvent exister dans d'autres affections.

(9:32 - 10:00)

Ce n'est pas du tout spécifique. Et on recherchera également par l'interrogatoire à l'organisme les différences d'infection bactérienne, de myalgie, d'arthralgie inflammatoire, de manifestations systémiques. Mais ce qui fait ou alors ce qui coûte à faire le diagnostic ou alors à penser au diagnostic c'est essentiellement l'association de manifestations pulmonaires, neurologiques, systémiques, RNA.

(10:01 - 10:36)

Essentiellement, quand vous avez un patient qui a une atteinte ORL, une atteinte pulmonaire RNA, il faut conserver un fil de surveillance. Alors on a regardé tout à l'heure pour la peau, essentiellement le cuir à l'atteinte, mais aussi le cuir d'électronique. Pour l'atteinte pulmonaire, on peut avoir au niveau du scanner, soit des infiltrats, soit des modules dans le cadre de la maladie de Wegener, dans le cadre du cuir de Strauss et de la polyarthrite systémique.

(10:37 - 10:56)

Donc là, on peut avoir des infiltrats. Des modules pulmonaires sont observés essentiellement au cours de la polyarthrite systémique de Wegener et au cours du cuir de Strauss. Et l'atteinte, avec l'hyperéosinophilie, ainsi que rapidement, c'est en faveur du diagnostic du cuir de Strauss.

(10:56 - 11:57)

Sur le plan rénal, c'est une insuffisance rénale rapidement progressive. La biopsie rénale a un intérêt

diagnostic sur la petitesse chronique et, très souvent, c'est une glomérule extracapillaire avec très peu de dépôts, voire pas de dépôts au niveau des glomérules, des compléments et des diminoglobulines, ce qu'on appelle aussi la sclérite. Alors, les glomérules sont aussi immunes parce qu'il n'y a pas de dépôts des diminoglobulines, les compléments au niveau de la glomérule.

Alors, voici quelques éléments qui peuvent distinguer les trois entités. L'éosinophilie, elle est très fréquente dans le sort de Strauss, un peu moins fréquente dans la maladie de Wegener. L'inflammation granulomateuse est surtout caractéristique de la granulomateuse de Wegener et du sort de Strauss, il n'y a pas de granulone dans la polyangéitique aussi.

(11:58 - 12:31)

Les neuropathies, c'est l'atteinte du sort de Strauss, peut être observée aussi dans les deux autres adjectifs. La glomérulonérite, ça caractérise essentiellement la maladie de Wegener et la polyangéitique du nucléaire correspond au anticorps anti myelopérotidose. Alors, les examens radiologiques, c'est essentiellement la tomographie, le scanner de signe et d'écoulement.

(12:32 - 13:51)

Les premiers rangs pour caractériser la pente neurologique sont les biopsies. Alors, le cycle le plus rentable pour Wegener, c'est essentiellement le reins et les nerfs et les poumons. Alors, les diagnostics différentiels s'opposent avec plusieurs infections, notamment les maladies granulomateuses, telles que la farinose et la maladie des crampes.

Les infections telles que la privacine, la mycoplasme et l'endocardite infectieuse de toute façon, sur ces patients-là, vous avez un caractère avertisseur avec une altération de l'état général et une fausse. Aussi, éliminer l'endocardite infectieuse est systématiquement une tomographie perverse. Un examen de laurée gauche, là aussi, ça peut donner les mêmes manifestations psychologiques.

Les examens de dictature, les examens d'intérêt génétique et certains concepts émotroniques peuvent aussi prêter à conclusion avec l'arrêt psychologique. Alors, le bilan a demandé pour les diagnostics. Bien sûr, les sérologies virales devaient être veillantes pour éliminer ces différences avec le vaccin antisémitique.

(13:52 - 15:32)

La sérologie du parvulisme de 19, les sérologies H1V, H1-parvulisme, comme vous le savez, ces infections virales peuvent entraîner des manifestations systémiques de la maladie. Les émorphiques et l'échographie composée. Les facteurs de mauvais pronostic sont en nombre distincts.

Essentiellement, l'élévation de la créativité immunitaire au-delà de 15 jours d'immunité nous rend

pas plus. Les différences d'une protéine humide, de l'infection d'infection intestinale sévère, comme l'hémorragie du vestibule, des castrations, d'une cardiomyopathie objectivée sur l'électrocardiogramme aussi, sur l'hébdoméde de l'hémorragie, d'une atteinte du système nerveux central, et ces facteurs de mauvais pronostic sont corrélés à la mortalité. Quand il n'y a pas de facteurs de mauvais pronostic, parmi les 5 facteurs qu'on a cités tout à l'heure, la mortalité est de 18%.

Quand il y a un facteur, cette mortalité est de 25%. Et quand il y a deux facteurs ou plus, cette mortalité est de 40%. Le traitement est basé sur les immunosuppresseurs, avec corticothérapie embolique quand on a une atteinte grave, suivie par de l'ambuction en cas suivant intraveineuse, et dans les cas qui ne répondent pas aux corticoïdes immunosuppresseurs, on peut faire appel à d'autres thérapeutiques, telles que les essences plasmatiques et le reflux climatique, qui en ont juste besoin.

(15:32 - 15:46)

Les plasmas thérapeutiques sont aussi très stricts, quand on a une atteinte suivie qui est très grave. Alors là, vous avez une idée.